

• 专科护理 •

基于 Donabedian 三维质量理论的母乳喂养咨询门诊护理质量评价指标体系构建

曾 华 林茵茵 邓蓓薇 殷彩欣 张小燕

【摘要】 目的 构建母乳喂养咨询门诊护理质量评价体系,为母乳喂养咨询门诊服务质量评价提供参考依据。**方法** 以 Donabedian“结构—过程—结果”三维质量理论为理论基础,结合文献回顾、半结构式访谈、专家函询,构建母乳喂养咨询门诊护理质量评价指标体系。**结果** 两轮专家函询的问卷有效回收率均为 100%。两轮函询中,专家权威系数分别为 0.941 和 0.953,肯德尔和谐系数分别为 0.168 和 0.213。最终,构建了包含 3 个一级指标、12 个二级指标以及 66 个三级指标的母乳喂养咨询门诊护理质量评价指标体系。**结论** 本研究所构建的母乳喂养咨询门诊护理质量评价体系具备高可靠性、科学性与实用性,能够为母乳喂养咨询门诊的护理质量评价工作提供有力的参考和依据。

【关键词】 母乳喂养咨询门诊;护理门诊;护理质量;评价指标;德尔非法

Construction of a nursing quality evaluation index system for breastfeeding counselling clinics based on Donabedian three-dimensional quality theory

ZENG Hua, LIN Yinyin, DENG Beiwei, YIN Caixin, ZHANG Xiaoyan, Obstetrics Department, Women's and Children's Medical Center Affiliated to Guangzhou Medical University, Guangzhou 510623, China.

Corresponding author: LIN Yinyin, E-mail: lovingyin@qq.com

【Abstract】 Objective To establish a nursing quality evaluation system for breastfeeding consultation clinics, so as to provide reference for the evaluation in this field. **Methods** Based on Donabedian's structure-process-result three-dimensional quality theory, a nursing quality evaluation system for breastfeeding consultation outpatient care was constructed after the literature review, literature quality evaluation, semi-structured interviews and experts' letter consultation. **Results** In the two-round letter consultations, the effective response rate both achieved 100%, the expert authority coefficients were 0.941 and 0.953, and the Kendall's harmony coefficients were 0.168 and 0.213, respectively. The final evaluation system included 3 first-level indicators, 12 second-level ones, and 66 third-level ones. **Conclusion** The nursing quality evaluation system for breastfeeding counselling clinics is reliable, scientific and practical, which is a good basis and reference for related evaluation.

【Keywords】 Breastfeeding consultation clinic; Nursing clinic; Nursing quality; Evaluation indicators; Delphi method

纯母乳喂养是 6 个月内婴儿的最佳喂养方式。2021 年我国发展研究基金会发布的报告显示,我国 6 个月内婴儿纯母乳喂养率为 29.2%,显著低于世界水平(43%)及中低收入国家水平(37%)^[1]。这一现象与我国孕产妇普遍缺乏系统性的母乳喂养指

导、产后母乳喂养自我效能不足密切相关。研究表明,设立母乳喂养咨询门诊能够切实协助孕产妇应对母乳喂养过程中的多种难题,从而提高纯母乳喂养率,延长母乳喂养持续时间^[2]。尽管母乳喂养咨询门诊在国外已较为普及,但在我国仍处于探索和

DOI:10.3969/j.issn.1674-3768.2026.04.004

基金项目:2023 年广东省护士协会科研课题项目(编号:gdshsxh2023ms69)

作者单位:广州医科大学附属妇女儿童医疗中心产科,广州 510623

通信作者:林茵茵, E-mail:lovingyin@qq.com

收稿日期:2025-02-20

发展阶段^[3],当前,这类门诊面临着数量不足、管理机制不完善以及设立和诊疗流程不规范等问题。在此背景下,建立科学的质量评价体系对保障服务质量至关重要。Donabedian 三维质量理论框架是医疗服务质量评价的经典框架,包括 3 个核心维度:结构(structure)——提供服务所需的硬件和软件基础;过程(process)——服务提供中的具体行为;结果(outcome)——服务产生的效果^[4]。该框架强调三者间的逻辑关系:良好的结构支撑,有效的过程,进而改善结果。已有研究将 Donabedian 三维质量理论框架应用于各项护理质量评价指标体系的构建,均显示出良好效果^[5-6],可系统、全面地评估结构、过程和结果,精准识别改进方向,提升护理服务的有效性和可持续性。但目前尚未见该框架应用于母乳喂养咨询门诊护理质量评价指标体系构建的相关研究报道。因此,本研究依据 Donabedian 三维质量理论框架^[7],致力于开发一套针对母乳喂养咨询门诊护理质量的评价指标体系,旨在为客观评判其服务品质提供有力依据。

1 方法

1.1 成立研究小组

研究小组包括主任护师 1 名,主要从事母乳喂养护理与护理管理相关工作,负责专业知识指导和研究项目审核;副主任护师 1 名,主要从事护理管理工作,负责研究设计和全程质量管控,确定入选专家条件并选定函询专家;主管护师 2 名,主要从事产科临床护理工作,负责访谈,编制、发放和回收专家函询问卷;护理研究生 2 名,负责文献检索和资料收集,依据专家返回意见进行整理和统计分析。小组成员均受过系统的循证护理培训,掌握循证的原则和方法。

1.2 构建初步条目

通过检索中国知网、万方数据知识服务平台、维普数据库、中国生物医学文献服务系统、PubMed、Web of Science、Embase 和护理与相关健康文献累积索引等数据库,结合《中华人民共和国母婴保健法》《“健康中国 2030”规划纲要》以及《母乳喂养促进行动计划 2021—2025 年》等相关政策文件,收集母乳喂养、护理门诊、护理质量等方面的研究资料。采用主题词结合自由词、关键词的方法,制定文献检索策略。中文检索词:“母乳喂养”“护理门诊/护理专科门诊”“护理质量/质量评价/敏感指标/指标体系”。英文检索词:“breastfeeding/breast-fed”“nurse-led clinic/

nurse led clinics/nurse-led center/nurses' practice patterns/nurse's practice patterns/nurse-managed health center/nurse-managed health clinic”“nursing quality/quality evaluation/quality indicators/quality metrics/sensitive indicators/sensitive index/system construction/structure-process-outcome model/SERVQUAL model”。检索时限为 2018 年 6 月 1 日—2023 年 6 月 30 日。选取母乳喂养咨询门诊出诊护士及门诊护理管理者作为访谈对象,采用面对面访谈方式探讨母乳喂养门诊护理质量评价的相关主题。访谈提纲如下:(1)是否愿意成为母乳喂养咨询门诊的出诊人员;(2)成为出诊人员所需具备的能力;(3)如何评价母乳喂养咨询门诊的护理质量及其具体内容;(4)影响护理质量的因素及改进建议。通过对访谈资料的编码和归纳,总结出诊室设施设备、政策制度、患者评估、护理干预及健康教育等多个主题。结合文献研究与半结构访谈结果,在 Donabedian 三维质量理论框架下,初步拟定包含 3 个一级指标、11 个二级指标以及 65 个三级指标的母乳喂养咨询门诊护理质量评价体系。

1.3 专家函询

1.3.1 遴选函询专家

专家遴选标准:本科及以上学历,中级及以上职称,从事产科、母乳喂养咨询工作 10 年以上。研究共纳入来自广东省的 13 名专家:均为女性;学士 9 名、硕士 4 名;中级职称 4 名、副高级职称 3 名、正高级职称 6 名;工作年限 10~<20 年 5 名、20~<30 年 6 名、≥30 年 2 名;专业领域涵盖护理管理 8 名、临床护理 5 名。

1.3.2 设计并发放咨询问卷

设计专家函询问卷,包括 3 部分:第 1 部分介绍研究目的及要求;第 2 部分调查各指标的重要性,采用 Likert 5 级量表进行评分(1 分表示“非常不重要”,5 分表示“非常重要”),同时设置“意见修改”栏,专家可提出修改意见或删减意见以及理由;第 3 部分收集专家的基本信息,对调查内容的判断依据(Ca)和对内容的熟悉程度(Cs)。通过电子邮件和微信等方式向 13 名专家进行两轮函询。第 1 轮函询问卷回收后,研究小组成员根据专家提供的意见进行修改、汇总后,形成第 2 轮函询问卷。2 轮函询后,专家意见趋于一致,函询结束。指标纳入标准需要同时满足以下条件:重要性得分均值>3.50 分且变异系数<0.25。

1.4 统计学方法

利用 SPSS 25.0 与 Excel 2019 对数据进行统计处理,计数资料以例数、百分比(%)形式描述,符合正态分布的计量资料采用均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示,运用层次分析法来明确各层级指标的权重^[8],采用问卷有效回收率表示专家积极性,采用权威系数表示专家权威性,采用变异系数和肯德尔和谐系数表示专家的意见一致程度和协调程度,以 $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 专家的积极性和权威性

本研究共进行两轮专家函询,问卷有效回收率均为 100%。两轮函询分别有 5 名和 2 名专家提出修改意见。意见提出率分别为 38.46%和 15.38%,说明专家对参与本研究的积极性较高。两轮专家函

询的权威系数分别为 0.941、0.953,其中熟悉程度分别为 0.933、0.953,判断依据为 0.950、0.953。

2.2 专家意见协调程度

两轮专家函询肯德尔和谐系数分别为 0.168 ($\chi^2 = 174.278, P < 0.001$)和 0.213 ($\chi^2 = 197.145, P < 0.001$)。

2.3 专家函询结果

在第 1 轮专家函询中,依据指标筛选准则,通过小组研讨并综合专家反馈,对指标进行了如下调整:将“诊室制度与政策”二级指标精简为“诊室制度”,将“诊室护理实践”调整为“诊室护理干预”,新增“医院政策”二级指标。对 17 个三级指标进行修订,新增 1 项。进入第 2 轮专家咨询后,一级和二级指标未修改,仅对 2 个三级指标进行微调。最终成功构建母乳喂养咨询门诊护理质量评价体系,该体系由 3 个一级指标、12 个二级指标以及 66 个三级指标共同组成,见表 1。

表 1 母乳喂养咨询门诊护理质量评价指标体系

指标	重要性赋值 ($\bar{x} \pm s$, 分)	变异 系数	权重	组合 权重
1 结构指标	4.692±0.480	0.102	0.328	0.328
1.1 诊室人力资源	4.538±0.519	0.114	0.203	0.066
1.1.1 每周出诊人次	4.308±0.630	0.146	0.188	0.012
1.1.2 护士准入资质	4.846±0.376	0.078	0.211	0.014
1.1.3 母乳喂养专科护士占比	4.308±0.480	0.111	0.188	0.012
1.1.4 多学科团队组建	4.692±0.480	0.102	0.205	0.014
1.1.5 出诊人员定期培训	4.769±0.439	0.092	0.208	0.014
1.2 诊室设施设备	4.462±0.519	0.116	0.199	0.065
1.2.1 手卫生、清洁消毒灭菌、诊疗等设备完备率	4.538±0.519	0.114	0.247	0.016
1.2.2 有婴儿体重秤,精确到小数点后两位	4.615±0.650	0.141	0.251	0.016
1.2.3 有乳盾、乳旁加奶器、乳头测量尺、医用吸奶器(并在使用期限内)	4.462±0.776	0.174	0.243	0.016
1.2.4 有母乳喂养宣教视频和宣传手册(需要根据母乳喂养政策和指南实时更新)	4.769±0.439	0.092	0.259	0.017
1.3 诊室环境布局	4.385±0.506	0.115	0.196	0.064
1.3.1 环境温湿度适宜、整洁、温馨	4.385±0.506	0.115	0.509	0.033
1.3.2 功能布局合理,各类指示标识清楚准确	4.231±0.725	0.171	0.491	0.032
1.4 诊室制度	4.462±0.519	0.116	0.199	0.065
1.4.1 制定诊室基本管理制度	4.462±0.519	0.116	0.162	0.011
1.4.2 制定患者就诊流程、服务范围制度	4.615±0.506	0.110	0.167	0.011
1.4.3 制定护士工作职责	4.692±0.480	0.102	0.170	0.011
1.4.4 制定护士母乳喂养专科护理操作规范	4.692±0.480	0.102	0.170	0.011
1.4.5 制定护理门诊收费项目	4.462±0.519	0.116	0.162	0.011
1.4.6 制定母乳喂养咨询门诊教学培训计划	4.692±0.480	0.102	0.169	0.011
1.5 医院政策	4.538±0.519	0.114	0.203	0.066
1.5.1 制定医院支持政策	4.692±0.480	0.102	0.517	0.034
1.5.2 制定护士薪酬、绩效考核方案	4.385±0.506	0.115	0.483	0.032
2 过程指标	4.846±0.376	0.078	0.339	0.339
2.1 就诊患者评估	5.000±0.000	0	0.212	0.072
2.1.1 一般情况评估准确率	4.769±0.439	0.092	0.101	0.007
2.1.2 母乳喂养知识、技能掌握情况评估准确率	4.846±0.376	0.078	0.103	0.007
2.1.3 母乳喂养自我效能评估准确率	4.769±0.439	0.092	0.101	0.007

(续表)

指标	重要性赋值 ($\bar{x} \pm s$, 分)	变异 系数	权重	组合 权重
2.1.4 母乳喂养自我管理行为评估准确率	4.769±0.439	0.092	0.101	0.007
2.1.5 母亲焦虑抑郁评估准确率	4.692±0.480	0.102	0.100	0.007
2.1.6 母乳喂养并发症识别率	4.615±0.506	0.110	0.098	0.007
2.1.7 健康素养评估准确率	4.462±0.519	0.116	0.095	0.007
2.1.8 母乳喂养态度评估准确率	4.769±0.439	0.092	0.101	0.007
2.1.9 社会支持系统评估准确率	4.769±0.439	0.092	0.101	0.007
2.1.10 患者紧急情况识别率	4.692±0.480	0.102	0.100	0.007
2.2 诊室护理干预	4.615±0.506	0.110	0.195	0.066
2.2.1 就诊患者咨询问题答复率	4.692±0.480	0.102	0.093	0.006
2.2.2 患者母乳喂养并发症诊断准确率	4.692±0.480	0.102	0.093	0.006
2.2.3 患者母乳喂养个性化指导实现率	4.846±0.376	0.078	0.096	0.006
2.2.4 患者个性化随访方案的制定实现率	4.615±0.506	0.110	0.091	0.006
2.2.5 患者及家属母乳喂养知识普及率	4.538±0.519	0.114	0.090	0.006
2.2.6 乳房按摩、催乳等护理操作规范率	4.538±0.519	0.114	0.090	0.006
2.2.7 乳房理疗仪、医用吸奶器操作规范率	4.385±0.768	0.175	0.086	0.006
2.2.8 心理干预能力	4.615±0.506	0.110	0.091	0.006
2.2.9 护理文书书写合格率	4.385±0.506	0.115	0.086	0.006
2.2.10 配偶及照护者母乳喂养支持率	4.692±0.480	0.102	0.093	0.006
2.2.11 患者转诊及时率	4.692±0.480	0.102	0.093	0.006
2.3 母乳喂养健康宣教	4.846±0.376	0.078	0.205	0.070
2.3.1 患者母乳喂养支持组织及咨询电话知晓率	4.615±0.506	0.110	0.089	0.006
2.3.2 患者获取母乳喂养知识途径知晓率	4.769±0.439	0.092	0.092	0.006
2.3.3 有清晰的母乳量异常(泌乳不足、泌乳过多)知识、技能宣教流程	4.846±0.376	0.078	0.093	0.006
2.3.4 有清晰的乳房问题(乳头皲裂、乳头疼痛、乳房肿胀等)知识、技能宣教流程	4.846±0.376	0.078	0.093	0.006
2.3.5 有清晰的婴儿因素(早产儿、双胎、新生儿呛奶等)相关母乳喂养知识、技能宣教流程	4.846±0.376	0.078	0.093	0.006
2.3.6 有清晰的心理调适知识、技能宣教流程	4.692±0.480	0.102	0.090	0.006
2.3.7 有清晰的疾病因素(病毒感染、长期用药)等相关母乳喂养知识、技能宣教流程	4.692±0.480	0.102	0.090	0.006
2.3.8 有清晰的母乳贮存知识、技能宣教护理操作流程	4.846±0.376	0.078	0.093	0.006
2.3.9 有清晰的回奶方法知识、技能宣教护理操作流程	4.615±0.506	0.110	0.089	0.006
2.3.10 有清晰的营养管理知识、技能宣教护理操作流程	4.692±0.480	0.102	0.090	0.006
2.3.11 有清晰的婴幼儿辅食添加知识、技能宣教护理操作流程	4.538±0.660	0.145	0.087	0.006
2.4 就诊档案管理	4.538±0.519	0.114	0.192	0.065
2.4.1 患者建档率	4.538±0.519	0.114	0.504	0.033
2.4.2 患者病历书写完整准确率	4.462±0.519	0.116	0.496	0.032
2.5 患者随访管理	4.615±0.506	0.110	0.195	0.066
2.5.1 患者按计划随访率	4.692±0.480	0.102	0.353	0.023
2.5.2 多元随访形式提供率	4.231±0.599	0.142	0.318	0.021
2.5.3 随访记录合格率	4.385±0.506	0.115	0.329	0.022
3 结果指标	4.769±0.439	0.092	0.333	0.333
3.1 患者结局	4.846±0.376	0.078	0.512	0.171
3.1.1 个性化母乳喂养指导方案完成率	4.615±0.506	0.110	0.146	0.025
3.1.2 母乳喂养知识、技能掌握率	4.615±0.506	0.110	0.146	0.025
3.1.3 母乳喂养自我效能评分	4.462±0.519	0.116	0.141	0.024
3.1.4 患者焦虑、抑郁发生率	4.538±0.660	0.150	0.144	0.025
3.1.5 母乳喂养并发症发生率	4.692±0.480	0.102	0.148	0.025
3.1.6 产后 42 d 纯母乳喂养率	4.385±0.506	0.115	0.139	0.024
3.1.7 婴儿 0~6 个月纯母乳喂养率	4.308±0.480	0.111	0.136	0.023
3.2 满意度	4.615±0.506	0.110	0.488	0.163
3.2.1 医护人员对母乳喂养咨询门诊的满意度	4.615±0.506	0.110	0.326	0.053
3.2.2 患者及家属对母乳喂养咨询门诊的满意度	4.769±0.439	0.092	0.337	0.055
3.2.3 患者及家属对就诊后效果的满意度	4.769±0.439	0.092	0.337	0.055

3 讨论

3.1 母乳喂养咨询门诊护理质量评价指标体系具有较好的科学性

本研究通过文献回顾与半结构式访谈,明确影响母乳喂养咨询门诊护理质量评价的关键因素,基于 Donabedian 三维质量结构理论框架,初步构建母乳喂养咨询门诊护理质量评价指标体系专家咨询问卷,该问卷历经两轮专家调研后,最终确立母乳喂养咨询门诊护理质量的评价指标。研究结论的可靠性和科学性,与专家的参与度、权威性 & 意见一致性紧密相关^[9]。本研究专家函询两轮的问卷回收率均为 100%,两轮专家均提出有价值的反馈,说明专家积极性较高。两轮函询中专家权威系数分别为 0.941 和 0.953,显示出参与函询的专家权威性较好。本研究运用层次分析法来明确各层次指标的权重,并进行了严格的一致性检验。因此,本研究方法科学性较高。

3.2 构建母乳喂养咨询门诊护理质量评价指标体系的重要性

院后服务是围产期不可缺少的一环,对于保障、增进及支持母乳喂养具有关键作用,可确保父母及其婴儿获得必要的支持与适当照顾。为此,建立母乳喂养咨询门诊能够为孕产妇提供更多关于母乳喂养的专业知识与技能,有效应对母乳喂养中的难题,进而促进纯母乳喂养率的提升^[10]。尽管母乳喂养门诊在国外已相当普遍,但在我国仍处于发展阶段。目前,国内三级甲等医院及社区卫生服务中心已陆续设立母乳喂养咨询门诊^[2],旨在为孕产妇及家属提高母乳喂养咨询服务。但因缺少规范和指南,母乳喂养门诊的工作进行并不顺利,存在出诊人员资质不统一、母乳喂养设施不完善、母乳喂养咨询管理制度及职责不完善等问题^[11]。因此,建立母乳喂养咨询门诊质量评价指标体系,对规范母乳喂养咨询门诊的建设,提高母乳喂养咨询门诊的服务质量,推动母乳喂养咨询门诊进一步发展有重要意义。

3.3 母乳喂养咨询门诊护理质量评价指标体系内容分析

结构指标涵盖以下 5 个二级指标:诊室的人力资源配置、诊室设施设备、诊室环境布局、诊室制度以及医院政策,进一步细分为 19 个三级指标。其中二级指标中诊室人力资源、医院政策的组合权重最高,均为 0.066,说明母乳喂养咨询门诊设立的首要条件是医院政策的支持与出诊团队的组建。三级指

标中“医院支持政策的制定”组合权重最高,函询专家共同认为医院层面支持政策的制定在母乳喂养宣教和技术支持方面发挥核心作用,对母乳喂养咨询门诊工作的开展具有重要意义。医院支持政策的制定是母乳喂养咨询门诊能够合法、规范、稳定发展的根本依据和关键保障。政策的制定可以明确界定出诊护士的执业权限、服务项目和操作规范,使母乳喂养咨询门诊在法律和医院内部规章制度的框架内运行。同时能有效打破部门壁垒,促进多学科团队合作支持母乳喂养咨询门诊的工作开展^[12],为婴儿母亲们提供一个能够得到充分支持母乳喂养的医疗环境和支持体系,保护、促进和支持母乳喂养^[1]。

过程指标涵盖就診患者评估、诊室护理干预、母乳喂养宣教、就診档案管理以及患者随访管理 5 个二级指标及 37 个三级指标。在二级指标中,患者就診评估的组合权重最高(0.072)。大部分产妇在住院期间对母乳喂养未过多关注,出院后母乳量异常、乳头皲裂、乳房肿胀等问题接踵而来^[13],母乳喂养咨询门诊出診人员只有准确识别孕产妇在母乳喂养过程中遇到的困难,才能提供针对性的母乳喂养指导和帮助,因此患者就診评估指标的权重最高。二级指标中母乳喂养健康宣教的组合权重较高(0.070),婴幼儿母亲对母乳相关知识的认知能力影响母乳喂养稳定性、母乳喂养掌握度和熟练度^[14]。因此护理人员进行母乳喂养咨询工作的过程中,不仅要解决孕产妇现存的母乳喂养问题,同时应为产妇及家属提供系统化、持续化、个性化的母乳喂养健康教育,与产妇及其家属共同促成母乳喂养的实施。

结局指标涵盖患者结局和满意度 2 个二级指标和 10 个三级指标,其中二级指标患者结局组合权重最高(0.171)。专科护理门诊主要的评价指标是患者的临床结局^[15]。母乳喂养咨询门诊的设立旨在帮助孕产妇解决母乳喂养期间遇到的问题,促使患者能够有效应对有关并发症,减轻患者困扰,并致力于提升母乳喂养率。因此,将患者结局作为结局指标之一,不仅合理而且科学。研究表明,母乳喂养咨询门诊为解决哺乳中遇到的问题提供了科学途径,可降低母乳喂养并发症的发生率,有效增加产妇母乳喂养的信心,提高纯母乳喂养率及延长母乳喂养时间^[8,16]。提示出診人员不仅要关注孕产妇现存的护理问题,针对可预见的母乳喂养并发症,提供延续性服务^[17]。本研究结局指标不仅关注患者结局指标,还纳入了医护人员、患者及家属的满意度^[18],从客观及主观角度丰富母乳喂养咨询门诊

护理质量评价指标体系,保证了母乳喂养咨询门诊护理质量评价指标体系的合理性。

4 结论

本研究基于 Donabedian 三维质量理论,构建了母乳喂养咨询门诊护理质量评价指标体系。该体系不仅为规范母乳喂养门诊的开设和运行提供了可靠工具,也为未来进一步优化服务质量奠定了基础。下一步,我们将结合实际应用效果对指标体系进行持续改进和完善。

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] 中国发展研究基金会.中国母乳喂养影响因素调查报告[EB/OL].[2022-03-05].<https://www.cdrf.org.cn/jjhd/4853.jhtml>.
- [2] 杨小红,储晓彤,朱笑笑,等.母乳喂养咨询门诊的建立与实施效果[J].现代医学,2023,51(2):231-234.
- [3] 郭俏璇,张瑜君,龙云,等.母乳喂养门诊国内外发展现状[J].中国妇幼保健,2016,31(13):2756-2759.
- [4] 操晓红,代贝贝,姚伟,等.肾移植病房护理质量评价指标体系的构建[J].护士进修杂志,2022,37(18):1677-1681.
- [5] 刘柳,侯备,朱亚男,等.放射性核素治疗病房护理质量评价指标体系的构建[J].辐射防护,2024,44(5):554-561.
- [6] 韩云玲,李兰花.基于三维质量结构理论的造血干细胞移植病房护理质量评价指标体系的初步构建[J].护理学报,2019,26(13):26-29.
- [7] 任志方,高学莉,王艳玲,等.基于三维质量理论与服务质量

评价模型的“互联网+护理服务”质量评价指标体系的构建[J].中国护理管理,2022,22(3):391-396.

- [8] 马改荣,赵新鲜,奚慧琴,等.基于 Donabedian 三维质量模型的炎症性肠病患者延续护理质量评价指标构建[J].中国医学科学院学报,2024,46(5):692-699.
- [9] 孙敏,王燕,徐敏,等.中医护理门诊护理质量指标的构建[J].中医药管理杂志,2023,31(4):187-192.
- [10] 李舒娜.母乳喂养咨询门诊指导对提高母乳喂养率的临床效果观察[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(36):113.
- [11] 樊帆,林文璇,颜斐斐,等.广东省专科护理门诊管理规范的构建[J].中华护理杂志,2020,55(8):1217-1223.
- [12] 林润,陈晓欢,李文洲,等.母乳喂养专科护士核心能力评价指标的构建[J].护理学报,2022,29(20):65-69.
- [13] 李君琴,李雅岑.母乳喂养咨询门诊咨询情况调查分析[J].护理与康复,2017,16(3):238-240.
- [14] 蒙晓慧,黄秋红,温美灵,等.产前母乳喂养咨询门诊对提高母乳喂养率的临床效果分析[C]//广东省肿瘤康复学会.2023 年华南康复医学与护理研究学术会议论文集.南宁:广西医科大学第二附属医院,2023:3.
- [15] 陈明珠,付静侠,罗阳.婴儿母乳喂养延续护理的研究进展[J].中国护理管理,2019,19(12):1872-1876.
- [16] 刘婷,王好,赵宝婕.国内专科护理门诊实践模式的研究进展[J].循证护理,2022,8(16):2202-2205.
- [17] 胡振凤,王格,马金歌,等.国际认证哺乳顾问发展现状及研究进展[J].护士进修杂志,2021,36(7):610-613.
- [18] RANDALL S, CRAWFORD T, CURRIE J, et al. Impact of community based nurse-led clinics on patient outcomes, patient satisfaction, patient access and cost effectiveness: a systematic review[J].Int J Nurs Stud,2017,73:24-33.

(本文编辑:周婷)

(上接 216 页)

- [15] 李海燕,杨汀,姚反修,等.社区慢性阻塞性肺疾病患者运动能力及预后评估方法研究[J].中国全科医学,2021,24(10):1294-1297.
- [16] FINCH S, LASKA I F, ABO-LEYAH H, et al. Validation of the COPD assessment test (CAT) as an outcome measure in bronchiectasis[J]. Chest,2020,157(4):815-823.
- [17] LORIG K R, SOBEL D S, RITTER P L, et al. Effect of a self-management program on patients with chronic disease[J]. Eff Clin Pract, 2001,4(6):256-262.
- [18] 张美霞.慢性病管理自我效能感量表的汉化及应用研究[D].呼和浩特:内蒙古医科大学,2023.
- [19] MICHALOVIC E, JENSEN D, DANDURAND R J, et al. Description of participation in daily and social activities for individuals with COPD[J]. COPD,202,7(5):543-556.
- [20] 伍青,郭爱敏,赵艳伟.慢性阻塞性肺疾病患者呼吸困难信念现状分析[J].中国护理管理,2016,16(5):630-634.
- [21] 朱晓敏.慢性阻塞性肺疾病患者呼吸困难信念现状及影响

因素的相关研究[D].荆州:长江大学,2019.

- [22] 赵毛妮,席芳,杨杰,等.COPD 患者呼吸困难信念现状及影响因素分析[J].中华现代护理杂志,2022,28(18):2412-2416.
- [23] YOHANNES A M. Psychosocial support in pulmonary rehabilitation[J]. Respir Care,2024,69(6):664-677.
- [24] 宋晓卿,朱容颜,叶瑞,等.基于虚拟现实技术的恐惧调适护理对慢性阻塞性肺疾病患者呼吸困难恐惧及运动功能的影响[J].医学理论与实践,2025,38(22):3905-3907.
- [25] 缪小浪,钮美娥,韩燕霞,等.慢性阻塞性肺疾病患者呼吸困难恐惧影响因素及路径分析[J].护理学杂志,2024,39(18):37-41,47.
- [26] 卢才菊,黄琴,杨阳,等.5 次坐立试验在 COPD 患者肺康复训练中的应用价值[J].实用临床医学,2022,23(3):67-70.
- [27] 李娜.有氧运动联合低强度抗阻运动训练在重度慢性阻塞性肺疾病患者中的应用[J].中国临床护理,2021,13(2):115-118.
- [28] 刘彦彦,李雅洁,路寒冰,等.运动训练在慢性阻塞性肺疾病病人康复中的应用研究进展[J].护理研究,2023,37(11):1966-1972.

(本文编辑:周婷)